

Concours



جهة كلميم – واد نون

Guelmim Oued-Noun

Commun 2023

Avec Justification



[Lien Page Instagram](#)

PRÉPA
CONCOURS
MSPS



OFFRE DE PRÉPARATION AU CONCOURS DE
RECRUTEMENT- INSCRIPTION OUVERTE

1) Les corps interministériels des infirmiers et des techniciens de santé se composent de :

- A) cadre des infirmiers
- B) cadre des sages-femmes
- C) cadre des kinésithérapeutes
- D) cadre des assistants médicaux

2) Les services déconcentrés du ministère de la Santé et de la Protection sociale sont constitués de :

- A) direction régionale
- B) institut national d'hygiène
- C) délégation préfectorale et provinciale
- D) Fondation Hassan 2 pour les œuvres sociales

3) Le pôle des soins infirmiers est chargé des tâches suivantes :

- A) contribuer à la prévention des infections nosocomiales
- B) assurer la gestion des déchets hospitaliers
- C) organiser et gérer les archives de l'établissement
- D) coordonner et planifier les activités et programmes de soins et des services paramédicaux

4) Le Conseil des infirmiers et infirmières (CI) est chargé de :

- A) examiner et approuver le plan d'action annuel du centre hospitalier
- B) apprécier la qualité et la pertinence des soins infirmiers
- C) contribuer à la formation continue
- D) donner son avis sur les questions relatives à la prestation de soins infirmiers

5) L'estimation des besoins en médicament peut se faire par :

- A) la méthode de priorisation
- B) la méthode fondée sur la morbidité
- C) la méthode des 5M
- D) la méthode de la consommation

6) Font partie du système marocain national de santé :

- A) le secteur privé
- B) la médecine traditionnelle
- C) les services de santé relevant des collectivités locales
- D) les services des FAR

7) La transition épidémiologique est caractérisée par :

- A) un déclin des maladies non transmissibles
- B) une montée des maladies non transmissibles



- C) un défi supplémentaire pour la couverture médicale
- D) une augmentation des taux de la fécondité

8) Le dossier d'hospitalisation :

- A) peut être consulté par le patient ou son représentant légal
- B) est un document à caractère confidentiel
- C) accompagne le patient en cas de transfert
- D) est la propriété du patient

9) Le taux de mortalité maternelle (ENPSF 2018) est :

- A) 72,6 au niveau national / 100 000 NV
- B) 111,1 au niveau rural / 100 000 NV
- C) 44,6 au niveau rural / 100 000 NV
- D) 112,5 au niveau national / 100 000 NV

10) Parmi les indicateurs de production et performance hospitalière :

- A) taux de mortalité infanto-juvénile
- B) taux de dépistage de grossesse à risque
- C) la durée moyenne de séjour
- D) l'intervalle de rotation

11) Un objectif SMART signifie :

- A) social, modifiable, atteignable, réaliste et traçable
- B) social, mesurable, actif, réaliste et temporel
- C) spécifique, modifiable, actif, réaliste et traçable
- D) spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel

12) Selon la définition, les soins de santé primaire sont :

- A) territoires de base dans le découpage sanitaire
- B) adopté à la conférence d'Alma Ata en 2002
- C) soins essentiels curatifs, préventifs et promotionnels
- D) rendus universellement accessibles à tous

13) Les grandes catégories des déterminants de la santé sont :

- A) facteurs biologiques
- B) objectifs de développement millénaire
- C) habitudes de vie
- D) organisation du système de soins

14) Un indicateur est une variable qui :

- A) facilite la collecte des données
- B) permet de suivre et d'évaluer une activité



- C) nécessite une norme d'interprétation
- D) illustre une représentation graphique synthétique et visuelle

15) Un système de santé :

- A) a pour objectif d'améliorer la santé de la population desservie
- B) production de ressources humaines
- C) répondre aux attentes des gens avec respect et dignité
- D) assurer une protection financière contre les coûts de la mauvaise santé

16) Le centre de santé urbain de premier niveau assure :

- A) soins infirmiers
- B) suivi des maladies chroniques
- C) consultations spécialisées
- D) consultations de médecine générale

17) Les déchets médicaux et pharmaceutiques sont :

- A) composés d'ordures ménagères et emballages
- B) issus des activités de diagnostic, suivi, traitement
- C) tous les déchets des cliniques
- D) issus d'activités non médicales

18) La durée moyenne de séjour :

- A) nombre moyen de jours d'hospitalisation par malade
- B) indicateur d'accès aux soins
- C) indicateur de service de santé
- D) % de journées utilisées / capacité litière fonctionnelle

19) Les premières causes de mortalité au Maroc sont :

- A) maladies transmissibles
- B) maladies à transport hydrique
- C) maladies non transmissibles
- D) maladies endémiques

20) Le découpage du Maroc comporte :

- A) 82 provinces sanitaires
- B) 92 provinces sanitaires
- C) 12 régions sanitaires
- D) 16 régions sanitaires

21) La prévalence d'une maladie est :

- A) nombre de nouveaux cas
- B) nouveaux cas rapportés à la population



C) cas totaux (anciens + nouveaux) à un moment donné

D) nombre de personnes malades à un moment donné

22) La prévention primaire permet de :

A) diminuer la chronicité

B) lutter contre séquelles et invalidités

C) réduire la durée d'une maladie

D) diminuer l'apparition de nouveaux cas

23) La prévention secondaire est :

A) diminuer la prévalence

B) prévenir aggravations et complications

C) vaccination

D) rééducation pour prévenir détérioration

24) Les soins palliatifs :

A) soins de confort en fin de vie uniquement

B) approche coordonnée pour réduire incidence

C) font partie des soins promotionnels

D) préserver qualité de vie et soulager symptômes

25) La santé publique :

A) ensemble d'actions collectives pour protéger santé

B) agit sur l'environnement, programmes de prévention, crises

C) facteurs sociaux, économiques, environnementaux de santé

D) opposée à la santé privée

26) Les déterminants de santé :

A) processus donnant contrôle sur la santé publique

B) associés aux comportements, conditions de vie

C) soins prodigués en autonomie et collaboration

D) facteurs influençant santé, isolés ou combinés

27) La décontamination est :

A) suspension de particules inhalables

B) reconnaissance d'un danger

C) élimination/réduction agents biologiques et toxines

D) événement susceptible de causer dommage

28) En cas de blessure par aiguille/objet tranchant :

A) laver 30 min à l'eau + savon, laisser saigner

B) aviser responsable du département



- C) envoyer aiguille au laboratoire
- D) déclarer accident selon procédures

29) Principaux axes de la réforme du système de santé marocain :

- A) digitalisation
- B) revalorisation des ressources humaines
- C) mise à niveau de l'offre sanitaire
- D) bonne gouvernance

30) La commission administrative paritaire est consultée pour :

- A) avancement de grade/échelon
- B) congés exceptionnels
- C) concours de recrutement
- D) mise en disponibilité sur demande

31) Les centres de santé de 2ème niveau assurent :

- A) analyses biologiques de grossesse
- B) soins obstétricaux d'urgence de base
- C) prestations de premier niveau
- D) aucune réponse n'est juste

32) Instances de gouvernance du système de santé :

- A) Haute Autorité de soins et services
- B) agences régionales de santé
- C) établissement public du sang et dérivés
- D) groupements sanitaires territoriaux

33) La loi-cadre 06-22 est relative à :

- A) schéma régional de l'offre de soins
- B) système de santé et de l'offre de soins
- C) système national de l'offre de soins
- D) carte sanitaire nationale et régionale

34) Principes du système national de santé :

- A) équité d'accès
- B) continuité
- C) bonne gouvernance
- D) mutualisation des ressources

35) La généralisation de la protection sociale sera opérationnalisée durant :

- A) 3 ans (2021-2023)
- B) 5 ans (2021-2025)

C) 8 ans (2021-2029)

D) toutes les réponses sont justes

36) Origines de la stigmatisation des maladies mentales :

A) discriminer

B) séparer

C) stéréotyper

D) toutes les réponses sont justes

37) ODD et santé :

A) Objectif 3 : santé et bien-être à tout âge

B) Objectif 1 : santé des enfants et bien-être

C) Objectif 5 : sécurité alimentaire, nutrition, agriculture durable

D) toutes les réponses sont justes

38) Interventions de prévention secondaire :

A) dépistage du cancer du sein > 50 ans

B) apport de calcium après fracture

C) sport à l'école < 18 ans

D) arrêt tabac adultes > 18 ans

39) Accident d'exposition au sang :

A) accident de travail

B) notifié au médecin de travail

C) déclaré sous 72h

D) déclaré sous 24h à 48h

E) concerne uniquement professionnels de santé

40) Cancers les plus fréquents au Maroc :

A) prostate, col utérin, poumon

B) poumon, sang, os

C) col utérin, sein, poumon

D) sein, côlon, peau

E) aucune réponse juste

41) Lavage antiseptique des mains vise à :

A) éliminer flore transitoire

B) détruire agents infectieux non conventionnels

C) diminuer flore commensale

D) toutes les réponses sont justes

42) Diagnostic infirmier : atteinte intégrité peau par rougeur aux points d'appui :

A) potentiel

- B) réel
- C) possible
- D) risque

43) Le ministère de la Santé au Maroc comporte 12 directions centrales et 09 directions régionales :

- A) vrai
- B) faux



1) Les corps interministériels des infirmiers et des techniciens de santé se composent de :

- A) cadre des infirmiers
- B) cadre des sages-femmes
- C) cadre des kinésithérapeutes
- D) cadre des assistants médicaux

مرسوم رقم 2-17-535 صادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى

تحدث هيئة للممرضين وتقنيي الصحة مشتركة بين الوزارات، تتكون من الأطر الخمس التالية :

- إطار الممرضين ؛
- إطار القابلات ؛
- إطار تقنيي الصحة ؛
- إطار الممرضين ؛
- إطار المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي.

2) Les services déconcentrés du ministère de la Santé et de la Protection sociale sont constitués de :

- A) direction régionale
- B) institut national d'hygiène
- C) délégation préfectorale et provinciale
- D) Fondation Hassan 2 pour les œuvres sociales

Les services déconcentrés du ministère de la santé sont constitués des directions régionales de la santé et des délégations préfectorales et provinciales, instituées respectivement dans les ressorts territoriaux des wilayas de régions, et des préfectures, préfectures d'arrondissements ou provinces, telles qu'elles sont ...

بنك المعطيات القانونية

8944-Arrêté-de-L... < Document < <http://bdj.mmsp.gov.ma>



Arrêté de la ministre de la santé n° 1363-11 du 12 jourmada II ...

3) Le pôle des soins infirmiers est chargé des tâches suivantes :

- A) contribuer à la prévention des infections nosocomiales



B) assurer la gestion des déchets hospitaliers

C) organiser et gérer les archives de l'établissement

D) coordonner et planifier les activités et programmes de soins et des services paramédicaux



Sous section 2 : Le pôle des soins infirmiers

Article 7 : Missions du pôle

Le pôle des soins infirmiers est placé sous la responsabilité d'un cadre titulaire du diplôme d'état d'infirmier. Il a pour mission de veiller à la bonne gestion des unités de soins et de services paramédicaux. A cet effet, il est notamment chargé des activités suivantes :

- La coordination et la planification des activités et programmes de soins et de services paramédicaux,
- L'évaluation de leur qualité et performance,
- La contribution à la prévention des infections nosocomiales;
- La planification et la gestion des ressources destinées au personnel paramédical ;
- La contribution à l'élaboration et au suivi des programmes d'éducation sanitaire ;
- La contribution au développement de la recherche en soins infirmiers ;

Le pôle des soins infirmiers est structuré en deux ou plusieurs bureaux en fonction du volume des activités.

4) Le Conseil des infirmiers et infirmières (CI) est chargé de :

A) examiner et approuver le plan d'action annuel du centre hospitalier

B) apprécier la qualité et la pertinence des soins infirmiers

C) contribuer à la formation continue

D) donner son avis sur les questions relatives à la prestation de soins infirmiers



Article 19 : Attributions, organisation et modalités de fonctionnement du Conseil des infirmiers et infirmières (CII)

Le conseil est chargé :

- d'apprécier la qualité et la pertinence des soins infirmiers;
- de contribuer à la formation continue;
- de donner son avis sur les questions relatives à la prestation de soins infirmiers par l'hôpital, qui lui sont soumises par le directeur de l'établissement.

Le conseil se réunit une fois par trimestre et autant de fois que les besoins l'exigent. Son secrétariat est assuré par le chef du pôle des soins infirmiers.



5) L'estimation des besoins en médicament peut se faire par :

- A) la méthode de priorisation
- B) la méthode fondée sur la morbidité
- C) la méthode des 5M
- D) la méthode de la consommation

B. Choix des méthodes de quantification des besoins en substances sous contrôle et amélioration de cette quantification

44. Trois méthodes et leurs variantes sont couramment utilisées pour quantifier les besoins en substances sous contrôle: la méthode basée sur la consommation, la méthode basée sur les services et la méthode basée sur la morbidité. Comme il est indiqué à la section II.A, le choix de la méthode appliquée dépend de la disponibilité des données requises pour la quantification, des ressources disponibles et de la structure du système d'approvisionnement.

6) Font partie du système marocain national de santé :

- A) le secteur privé
- B) la médecine traditionnelle
- C) les services de santé relevant des collectivités locales
- D) les services des FAR



7) La transition épidémiologique est caractérisée par :

- A) un déclin des maladies non transmissibles
- B) une montée des maladies non transmissibles
- C) un défi supplémentaire pour la couverture médicale
- D) une augmentation des taux de la fécondité

Transition épidémiologique

Ou Transition sanitaire

Période de baisse de la mortalité qui accompagne la transition démographique. Elle s'accompagne d'une amélioration de l'hygiène, de l'alimentation et de l'organisation des services de santé et d'une transformation des causes de décès, les maladies infectieuses disparaissant progressivement au profit des maladies chroniques et dégénératives et des accidents.

8) Le dossier d'hospitalisation :

- A) peut être consulté par le patient ou son représentant légal
- B) est un document à caractère confidentiel
- C) accompagne le patient en cas de transfert
- D) est la propriété du patient

Section I

Le dossier d'hospitalisation

Article 60 : Constitution et gestion du dossier d'hospitalisation

Un dossier d'hospitalisation est constitué pour chaque patient hospitalisé. Le dossier d'hospitalisation est la propriété de l'hôpital qui en assure la conservation.

Dès la sortie du patient, le dossier d'hospitalisation est transmis au service en charge des archives médicales de l'hôpital. Dans certains cas, le directeur de l'hôpital peut accorder, en fonction des besoins de chaque département ou service, un délai supplémentaire de conservation du dossier dans les unités de soins avant son transfert aux archives médicales de l'hôpital.

Sous la responsabilité du chef du département ou de service et du chef de l'unité de soins ou des services concernés, les praticiens et les infirmiers sont tenus chacun en ce qui le concerne, de remplir au quotidien, exhaustivement et lisiblement le dossier d'hospitalisation.

Le personnel de l'hôpital doit prendre toutes les mesures adéquates pour sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements contenus dans le dossier d'hospitalisation.

Règlement Intérieur des Hôpitaux 2010

Article 61 : Consultation et communication du dossier d'hospitalisation

Le dossier d'hospitalisation peut être consulté par le patient ou son représentant légal, ses ayants droit en cas de décès par l'intermédiaire de son médecin traitant externe à l'hôpital.

Le patient ou son médecin représentant disposent du droit de consultation du dossier d'hospitalisation sur place, en présence du médecin hospitalier traitant.

Le patient peut se faire communiquer, par l'intermédiaire de son médecin hospitalier traitant, une copie du dossier hospitalier et/ou un compte rendu détaillé de sa prise en charge médicale, sur la base d'une demande présentée par le patient au directeur de l'hôpital.

En cas de transfert du patient vers un autre établissement hospitalier, le compte rendu détaillé, ainsi que la copie du dossier, dont le contenu doit être listé sur un bordereau de transmission, sont communiqués à l'établissement d'accueil, qui en accuse réception en signant une copie du bordereau.

Le dossier d'hospitalisation peut être communiqué dans un but scientifique à tout membre du corps médical en vue d'une consultation sur place, sur autorisation du directeur de l'hôpital.

Règlement Intérieur des Hôpitaux 2010



9) Le taux de mortalité maternelle (ENPSF 2018) est :

- A) 72,6 au niveau national / 100 000 NV
- B) 111,1 au niveau rural / 100 000 NV
- C) 44,6 au niveau rural / 100 000 NV
- D) 112,5 au niveau national / 100 000 NV

En utilisant la méthode d'estimation directe de la mortalité maternelle sur un échantillon de 121715 ménages (64577 en milieu urbain et 57148 en milieu rural), l'ENPSF-2018 a fourni un Ratio de Mortalité Maternelle de 72,6 pour 100000 naissances vivantes pour la période 2015-2016 (44,6 et 111,1 pour 100 000 NV respectivement en urbain et en rural), soit une diminution de 35% entre 2010 et 2016 et un taux de réduction annuelle moyenne de 7%.

Morbidité reproductive :

Les résultats de l'enquête concernant la proportion des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans ayant présenté des symptômes d'affections liées

10) Parmi les indicateurs de production et performance hospitalière :

- A) taux de mortalité infanto-juvénile
- B) taux de dépistage de grossesse à risque
- C) la durée moyenne de séjour
- D) l'intervalle de rotation

1.3. INDICATEURS DE PERFORMANCE

Programmes SMI/PF¹

Taux de prévalence contraceptive (en %) toutes méthodes

70,8%

Urbain 71,1% Rural 70,3%

% des femmes enceintes recevant les soins prénatals par un personnel qualifié

88,5%

Urbain 95,6% Rural 79,6%

% d'accouchements dans un établissement de santé

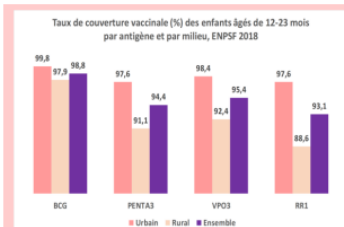
86,1%

Urbain 96,0% Rural 73,7%

% d'accouchements par césarienne

21,2%

Urbain 26,3% Rural 12,9%



Sources : 1 Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale, (ENPSF-2018)

7 SEIS/ DPE/ DPRF

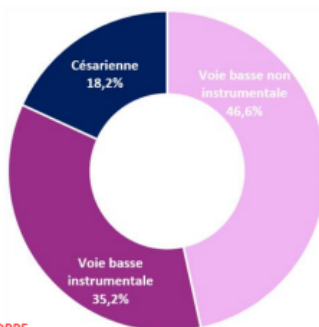
Consultations médicales et infirmiers dans les ESSP, année 2023 ⁷

	Urbain	Rural	Ensemble
Consultations médicales par habitant	0,44	0,30	0,39
Soins infirmiers par habitant	0,30	0,44	0,35

1.4. INDICATEURS DE PRODUCTION DES HOPITAUX PUBLICS ⁷

Capacité litière Fonctionnelle	22 938	Taux d'occupation moyen (TOM) en %	56,6
Capacité litière Existante	27 539	Durée moyenne de séjour (DMS) en jours	3,5
Nombre d'admissions	1 211 765	Intervalle de rotation en Jours (IROT)	2,7
Nombre de journées d'hospitalisation	4 263 968	Taux de rotation (TROT)	52,8
Nombre d'interventions chirurgicales	314 944	Nombre d'interventions chirurgicales par médecin	130
Nombre moyen de consultations Spécialisées externes par médecin	501		

Répartition des accouchements ayant lieu dans les services de maternités par type d'accouchement, année 2023



Source : 7 SEIS/ DPE/ DPRF

11) Un objectif SMART signifie :

- A) social, modifiable, atteignable, réaliste et traçable
- B) social, mesurable, actif, réaliste et temporel
- C) spécifique, modifiable, actif, réaliste et traçable
- D) spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel

SMART est un acronyme qui définit des critères permettant d'établir des buts et objectifs idéaux pour la gestion de personnel ou d'entreprise. Un objectif SMART doit être **spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel**. Pour travailler efficacement, les équipes doivent avoir des objectifs clairs à atteindre.

12) Selon la définition, les soins de santé primaire sont :

- A) territoires de base dans le découpage sanitaire
- B) adopté à la conférence d'Alma Ata en 2002
- C) soins essentiels curatifs, préventifs et promotionnels
- D) rendus universellement accessibles à tous

Que recouvrent les soins de santé primaires ?

Depuis 1978, le concept de soins de santé primaires a été réinterprété et redéfini à maintes reprises au fil des ans, ce qui a pu prêter à confusion tant dans la terminologie que dans la pratique. Une définition claire et simple a été formulée afin de faciliter la coordination des futurs efforts en la matière aux niveaux mondial, national et local et d'orienter leur mise en œuvre :

« Les soins de santé primaires constituent une approche de la santé tenant compte de la société dans son ensemble qui vise à garantir le niveau de santé et de bien-être le plus élevé possible et sa répartition équitable en accordant la priorité aux besoins des populations le plus tôt possible tout au long de la chaîne de soins allant de la promotion de la santé et de la prévention des maladies au traitement, à la réadaptation et aux soins palliatifs, et en restant le plus proche possible de l'environnement quotidien des populations. OMS et UNICEF. A vision for primary health care in the 21st century: towards universal health coverage and the Sustainable Development Goals.

13) Les grandes catégories des déterminants de la santé sont :

- A) facteurs biologiques
- B) objectifs de développement millénaire
- C) habitudes de vie
- D) organisation du système de soins

II. Différentes catégories

Il existe plusieurs catégories existantes pour classer ces déterminants de la santé.

4 grands groupes selon la classification de Lalonde

- Biologie humaine
- Environnement
- Comportement
- Organisation des services de santé



14) Un indicateur est une variable qui :

- A) facilite la collecte des données
- B) permet de suivre et d'évaluer une activité
- C) nécessite une norme d'interprétation
- D) illustre une représentation graphique synthétique et visuelle

INDICATEURS

Définition:

Un indicateur est une variable qui aide à mesurer les changements. Il donne une idée de grandeur sur une situation bien donnée ou reflète celle-ci.

Les indicateurs ont des valeurs scientifiques. Un indicateur doit être:

1. Valable: il doit être reconnu comme élément de mesure de ce qu'il est sensé mesurer,
2. Fiable: le résultat devrait être le même si la mesure est effectuée dans des conditions semblables par des personnes différentes à des moments différents.
3. Sensible: il devrait réagir aux modifications de la situation
4. Spécifique: refléter les modifications uniquement dans la situation en cause

Les indicateurs servent à mesurer par conséquent l'atteinte des objectifs.

INDICATEURS (suite)

Ils doivent être identifiés et fixés à l'étape de fixation des objectifs et non à l'évaluation où ils sont par contre utilisés.

Ainsi, selon le niveau dont on se situe dans le processus de résolution des problèmes, on distingue:

- les indicateurs d'intrant
- les indicateurs de processus
- les indicateurs de résultats
- les indicateurs d'impact

Aussi distingue-t-on les objectifs:

- d'intrant
- de processus
- de résultats
- et d'impact.

La même classification peut être opérée en ce qui concerne les problèmes



15) Un système de santé :

- A) a pour objectif d'améliorer la santé de la population desservie
- B) production de ressources humaines
- C) répondre aux attentes des gens avec respect et dignité
- D) assurer une protection financière contre les coûts de la mauvaise santé

I. DEFINITION

- ❑ Le système de santé peut être défini comme « *l'ensemble des moyens (organisationnels, structurels, humains, financiers) destinés à réaliser les objectifs d'une politique de santé* ».
- ❑ Pour l'OMS, on entend sous le terme de système de santé, « *toutes les activités, officielles ou non, qui portent sur les services de santé mis à la disposition d'une population et sur l'utilisation de ces services par la population* »

I. DEFINITION

- ❑ Le système de santé constitue un sous-système du système économique général
- ❑ Ses objectifs sont :
 - la **restauration de la santé**, c'est à dire la distribution des soins à l'individu malade
 - la **prévention**, qui est l'ensemble de mesures qui visent à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies et des accidents
 - la **promotion de la santé**, qui correspond à l'ensemble des moyens destinés à augmenter le capital santé de la population.

16) Le centre de santé urbain de premier niveau assure :

- A) soins infirmiers
- B) suivi des maladies chroniques
- C) consultations spécialisées
- D) consultations de médecine Générale

Le centre de santé rural de 1er niveau (CSR 1)

- ❑ C'est l'établissement de soins de santé primaires de **premier contact en milieu rural.**
- ❑ Il est placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major.
- ❑ Il offre des prestations de santé **préventives**, **curatives** et **promotionnelles** qui comprennent:
 - La surveillance épidémiologique ;
 - Les consultations de médecine générale ;
 - Les prestations de soins infirmiers ;
 - Le suivi de la santé de la mère et de l'enfant;
 - Le suivi des maladies chroniques ;
 - Le suivi de la santé des jeunes et des adolescents y compris la santé scolaire
 - Les prestations d'information et d'éducation pour la santé (IES).

17) Les déchets médicaux et pharmaceutiques sont :

- A) composés d'ordures ménagères et emballages



B) issus des activités de diagnostic, suivi, traitement

C) tous les déchets des cliniques

D) issus d'activités non médicales

Déchets d'activité de soins

Les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire



18) La durée moyenne de séjour :

A) nombre moyen de jours d'hospitalisation par malade

B) indicateur d'accès aux soins

C) indicateur de service de santé

D) % de journées utilisées / capacité litière fonctionnelle

La durée moyenne de séjour est le nombre moyen de jours que les patients passent à l'hôpital. Elle se calcule généralement en divisant le nombre total de jours passés en hospitalisation par l'ensemble des patients au cours de l'année par le nombre des admissions ou des sorties.

19) Les premières causes de mortalité au Maroc sont :

A) maladies transmissibles

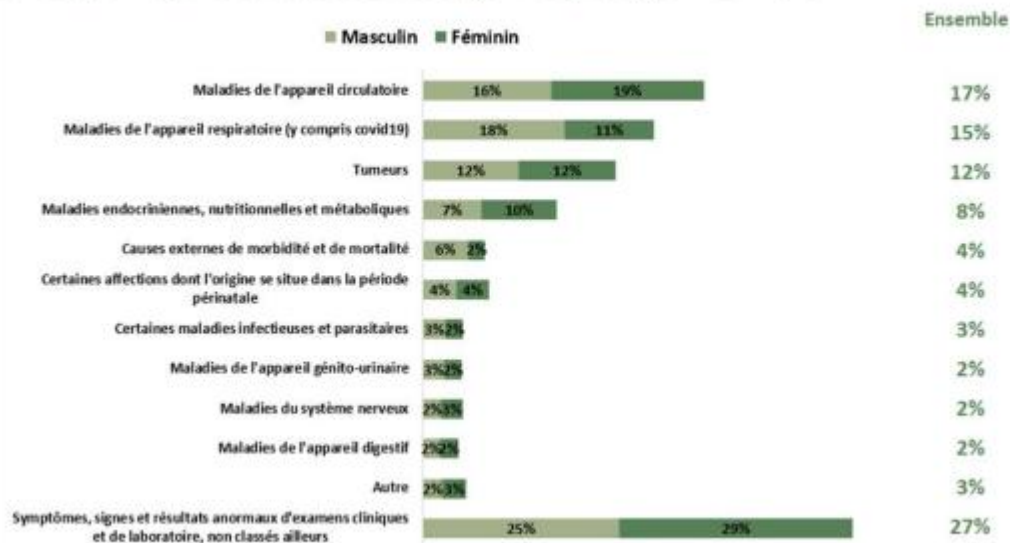
B) maladies à transport hydrique

C) maladies non transmissibles

D) maladies endémiques

1.6. PRINCIPALES CAUSES DE DECES (*)

Répartition des principales causes de décès (par chapitre), année 2020⁷



(*) Calculées sur la base des données reçues par le MS

Source : 7 SEIS/ DPE/ DPRF

20) Le découpage du Maroc comporte :

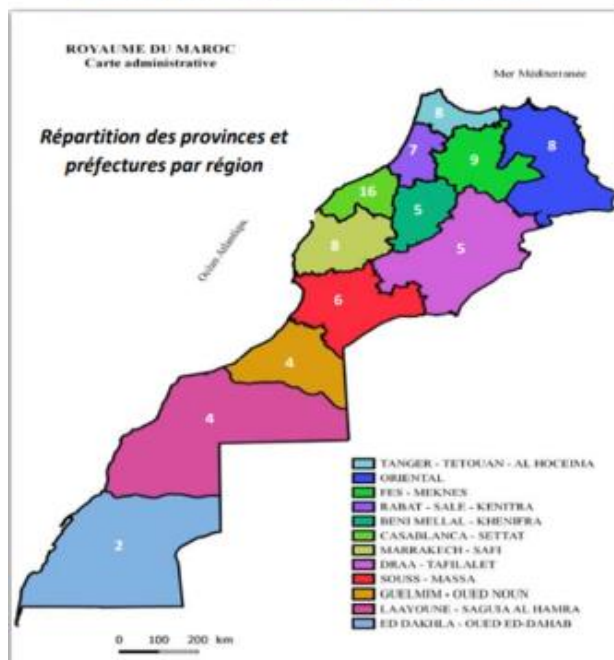
A) 82 provinces sanitaires

B) 92 provinces sanitaires

C) 12 régions sanitaires

D) 16 régions sanitaires

Découpage sanitaire, année 2022



s électroniques qcm

12

RÉGIONS SANITAIRES

82

PROVINCES SANITAIRES



21) La prévalence d'une maladie est :

- A) nombre de nouveaux cas
- B) nouveaux cas rapportés à la population
- C) cas totaux (anciens + nouveaux) à un moment donné
- D) nombre de personnes malades à un moment donné

Prévalence d'une maladie

Nombre de cas de maladies enregistrés pour une population déterminée et englobant aussi bien les nouveaux cas que les anciens cas.

~~Taux~~ de prévalence :

Nombre de personnes souffrant d'une maladie particulière à un moment donné, par population exposée au risque de cette maladie. Il est exprimé pour 1000 personnes

22) La prévention primaire permet de :

- A) diminuer la chronicité
- B) lutter contre séquelles et invalidités
- C) réduire la durée d'une maladie
- D) diminuer l'apparition de nouveaux cas

Prévention primaire

... **diminuer** l'incidence d'une maladie ou d'un problème de santé, donc à réduire l'apparition des nouveaux cas dans une population saine par la diminution ...

Niveaux de prévention et objectifs	Primaire (I) Éviter l'apparition de la maladie	Secondaire (II) Éviter le développement de la maladie	Tertiaire (III) Éviter l'aggravation de la maladie
Objectif visé par rapport aux maladies, accidents et handicaps	Diminuer l'incidence (le nombre de nouveaux cas)	Diminuer la prévalence (le nombre de cas totaux)	Limitier les complications, séquelles et récives
Périodicité d'intervention	Avant l'événement	À un stade précoce de développement	En aval de l'événement
Exemple de mesures	Campagne d'information et de sensibilisation, vaccination préventive	Dépistage précoce	Rééducation fonctionnelle et réadaptation

23) La prévention secondaire est :

- A) diminuer la prévalence



B) prévenir aggravations et complications

C) vaccination

D) rééducation pour prévenir détérioration

Niveaux de prévention et objectifs	Primaire (I) Éviter l'apparition de la maladie	Secondaire (II) Éviter le développement de la maladie	Tertiaire (III) Éviter l'aggravation de la maladie
Objectif visé par rapport aux maladies, accidents et handicaps	Diminuer l'incidence (le nombre de nouveaux cas)	Diminuer la prévalence (le nombre de cas totaux)	Limiter les complications, séquelles et récurrences
Périodicité d'intervention	Avant l'événement	À un stade précoce de développement	En aval de l'événement
Exemple de mesures	Campagne d'information et de sensibilisation, vaccination préventive	Dépistage précoce	Rééducation fonctionnelle et réadaptation

24) Les soins palliatifs :

A) soins de confort en fin de vie **uniquement**

B) approche coordonnée pour réduire l'incidence

C) font partie des soins promotionnels

D) préserver la qualité de vie et soulager les symptômes

Les Soins Palliatifs.

Définition de l'OMS (suite) :

- Soins ne visant PAS à la GUERISON.
- Soins visant à assurer une QUALITE DE VIE OPTIMALE pour le malade ET ses proches.

L'INAMI insiste en disant :

- « Le but principal des soins palliatifs est d'offrir au malade et à sa famille la meilleure qualité de vie et la plus grande autonomie possibles. Dans ce sens, ils sont une confirmation de la vie, et la mort est considérée comme un processus normal...Ils visent dès lors à améliorer la qualité de la vie qui subsiste encore... »

25) La santé publique :

- A) ensemble d'actions collectives pour protéger santé
- B) agit sur l'environnement, programmes de prévention, crises
- C) facteurs sociaux, économiques, environnementaux de santé
- D) opposée à la santé privée

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé publique représente « l'ensemble des efforts menés par des institutions publiques dans une société pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population, grâce à une action collective ». Il en résulte que le champ couvert par la santé publique est extrêmement vaste : surveillance épidémiologique, prévention et promotion de la santé, mesures de police sanitaire... La santé publique poursuit ainsi deux objectifs majeurs : réduire l'apparition des maladies et maintenir la population dans le meilleur état de santé possible. Compte tenu de l'étendue et de la diversité des champs de la santé publique, on recense une pluralité d'acteurs dans ce domaine : administrations publiques, agences de santé, collectivités territoriales, caisses d'assurance maladie, organismes complémentaires, professions libérales de santé, établissements de santé, médecine scolaire, associations... C'est pourquoi, dans un environnement aussi morcelé et complexe, il revient à l'État d'impulser, de coordonner, d'animer et d'évaluer la politique de santé publique afin de resituer l'action des différents acteurs dans le cadre d'une politique globale...

26) Les déterminants de santé :

- A) processus donnant contrôle sur la santé publique

- B) associés aux comportements, conditions de vie
- C) soins prodigués en autonomie et collaboration
- D) facteurs influençant santé, isolés ou combinés

Un **déterminant social de santé** en **santé publique**, est un facteur qui influence l'état de santé d'une **population** soit isolément, soit en association avec d'autres facteurs et sur lequel il est possible d'agir. Les déterminants sociaux de santé sont liés au revenu, à la formation, à l'emploi, ainsi qu'aux contextes sociaux et aux politiques publiques, etc.¹. Ils ont une influence significativement plus importante que les déterminants biologiques sur la santé des populations.

Les déterminants sont différents des **facteurs de risque** : « La notion de déterminant implique donc un rôle causal (pas forcément nécessaire ni suffisant) alors que la notion de facteur de risques est plus large et ne fait référence qu'à une probabilité plus élevée de la maladie chez les sujets exposés »².

Modèle des déterminants de la santé

27) La décontamination est :

- A) suspension de particules inhalables
- B) reconnaissance d'un danger
- C) élimination/réduction agents biologiques et toxines
- D) événement susceptible de causer dommage

Décontamination (d'après l'ISO 15190 :2003)

Procédure qui élimine ou réduit les agents biologiques et les toxines à un niveau sûr par rapport à la transmission d'une infection ou d'autres effets négatifs.

28) En cas de blessure par aiguille/objet tranchant :

- A) laver 30 min à l'eau + savon **desinfectant**, laisser saigner
- B) aviser responsable du département
- C) **envoyer aiguille au laboratoire**
- D) déclarer accident selon procédures

2.1 En cas de blessure par un objet tranchant ou piqûre par une aiguille :

La région exposée doit être lavée immédiatement :

- Enlever les équipements de protection individuelle (EPI) pour accéder à la zone touchée.
- Utiliser des pinces, si nécessaire pour retirer les fragments de verre.
- Laver la partie affectée pendant 30min avec de l'eau et du savon désinfectant tout en laissant la plaie saigner librement.
- Désinfecter avec de l'alcool à 70° ou appliquer un désinfectant approprié de la trousse de premiers soins existant au laboratoire et couvrir la plaie avec un pansement ou bandage. Ne pas utiliser les désinfectants chimiques forts qui peuvent irriter la peau comme l'eau de Javel.
- Aviser immédiatement le responsable biosécurité du département concerné, le chef du département, le responsable du laboratoire et le médecin du personnel.
- Pour toute piqûre ou tout contact corporel avec du liquide biologique, ou d'autres expositions aux dangers biologiques et chimiques, l'intéressé doit se rendre d'urgence au CHU de Rabat dans les deux heures suivant l'exposition afin d'assurer le suivi sérologique et/ou traitement médical approprié avec l'orientation du médecin du personnel. Dans tous les cas, il doit emporter avec lui la fiche technique de l'agent biologique/chimique auquel il a été exposé.
- Remplir la fiche de déclaration d'accident par la personne concernée en se référant à l'enregistrement EN79 (annexe 1) de la procédure hygiène et sécurité PR13.
- Remplir la fiche de déclaration des non-conformités avec actions correctives/actions préventives en se référant à l'enregistrement EN30 (annexe 3).
- Déclarer l'accident selon les démarches administratives en vigueur. Une copie de la fiche de déclaration doit être transmise au responsable biosécurité du département concerné et une à l'administrateur de l'INH et une copie de la fiche de non-conformité correspondante est à classer chez le responsable qualité dans les 24h qui suivent l'accident pour le suivi.
- La personne concernée par l'accident doit garder une copie de sa fiche de déclaration.

29) Principaux axes de la réforme du système de santé marocain :

A) digitalisation

B) revalorisation des ressources humaines

C) mise à niveau de l'offre sanitaire

D) bonne gouvernance



30) La commission administrative paritaire est consultée pour :

- A) avancement de grade/échelon
- B) congés exceptionnels
- C) concours de recrutement
- D) mise en disponibilité sur demande

La commission administrative paritaire est consultée pour les questions d'ordre suivantes:

- Titularisation des stagiaires,
- Avancement de grade sur choix et avancement d'échelon,
- Mise en disponibilité sur demande,
- Licenciement,
- Mise à la retraite d'office pour insuffisance professionnelle,
- Sanctions disciplinaires (Sauf avertissement et blâme),
- Démission (Dans le cas où la demande est rejetée par l'administration),
- Mutation pour nécessité de service.

31) Les centres de santé de 2ème niveau assurent :

- A) analyses biologiques de grossesse
- B) soins obstétricaux d'urgence de base SOUB
- C) prestations de santé de premier niveau
- D) aucune réponse n'est juste

CS 2 ^{ème} Niveau	Rural	Sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier chef.	➤ CSR 1 ^{er} niveau ➤ Les soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB) ; ➤ Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques ; ➤ Les examens d'échographie obstétricale. ➤ Lorsque le CS est implanté dans le chef-lieu d'un cercle administratif ne disposant pas de structure hospitalière, il est doté d'un module d'accouchement de 4 à 8 lits et délivre en plus : ➤ Des prestations d'urgence médicale de proximité ; ➤ Des soins bucco-dentaires ; ➤ Des consultations de santé mentale.	25 000 Hab
	Urbain		➤ Les soins obstétricaux d'urgence de base (SOUB) ; ➤ Les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques ; ➤ Les examens d'échographie obstétricale. ➤ 4 à 8 lits d'accouchement au besoin ; ➤ Lorsque le CS est implanté dans le chef-lieu de la commune de rattachement ne disposant pas de structure hospitalière, on ajoute les soins bucco-dentaires et les consultations de santé mentale	50 000 Hab

32) Instances de gouvernance du système de santé :

- A) Haute Autorité de soins et services
- B) agences régionales de santé
- C) établissement public du sang et dérivés
- D) groupements sanitaires territoriaux

Le ministre a indiqué que ce projet de loi s'articule sur quatre axes à savoir en premier lieu l'instauration d'une nouvelle gouvernance sanitaire à travers la création d'instances de gestion et de gouvernance comprenant notamment la Haute autorité de santé, les groupements sanitaires territoriaux, l'Agence nationale du médicament et des produits de santé ainsi que l'Agence du sang.

33) La loi-cadre 06-22 est relative à :

- A) schéma régional de l'offre de soins
- B) système de santé National et de l'offre de soins
- C) système national de l'offre de soins
- D) carte sanitaire nationale et régionale

Dahir n° 1-22-77 du 14 jourmada I 1444 (9 décembre 2022)
portant promulgation de la loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santé.

34) Principes du système national de santé :

- A) équité d'accès
- B) continuité
- C) bonne gouvernance
- D) mutualisation des ressources

Article 4

Le système national de santé est basé sur les principes suivants :

- l'égalité d'accès aux soins et aux prestations de santé ;
- la continuité des prestations de santé ;
- l'équité et l'équilibre dans la répartition spatiale des ressources, des structures et des prestations de santé sur l'ensemble du territoire national ;
- la bonne gouvernance ;
- l'adoption de l'approche genre dans l'élaboration des politiques, des programmes et des stratégies de santé ;
- la gestion basée sur les résultats et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes ;
- la mutualisation des moyens ;
- la mobilisation de l'ensemble des citoyennes et citoyens, des institutions, des organismes relevant des secteurs public et privé ainsi que des associations de la société civile et leur implication dans l'exécution de la politique de l'Etat relative à la prévention des épidémies, des maladies et des autres risques sanitaires, et celle relative aux programmes visant l'amélioration de la situation sanitaire de la population et la disponibilité des soins de santé de base.

35) La généralisation de la protection sociale sera opérationnalisée durant :

- A) 3 ans (2021-2023)
- B) 5 ans (2021-2025)
- C) 8 ans (2021-2029)
- D) toutes les réponses sont justes



Cette réforme sera déployée dans un délai de cinq ans, selon le calendrier suivant :

- la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base en 2021 et 2022 ;
- la généralisation des allocations familiales en permettant aux familles qui ne bénéficient pas de telles allocations conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, de bénéficier, selon le cas, d'indemnités de protection contre les risques liés à l'enfance ou d'allocations forfaitaires et ce, au cours des années 2023 et 2024 ;
- l'élargissement de l'affiliation aux régimes de retraite et la généralisation du bénéfice des indemnités de perte d'emploi en 2025.

36) Origines de la stigmatisation des maladies mentales :

- A) discriminer
- B) séparer
- C) stéréotyper
- D) toutes les réponses sont justes

1. INTRODUCTION : STIGMATISATION ET STÉRÉOTYPE

La lutte contre la stigmatisation des maladies mentales ou psychiatriques^[1] est une préoccupation affichée des pouvoirs publics¹, et fait l'objet d'un nombre croissant de publications scientifiques². La conceptualisation de la stigmatisation par Link et Phellan³ présente quatre composantes qui interagissent en cascade : la reconnaissance des marques des différences humaines ; l'émergence de stéréotypes ; la catégorisation et séparation des groupes d'individus (ou distance sociale entre « eux » et « nous ») ; et enfin la perte de statut et la discrimination menant à des inégalités. La stigmatisation a donc pour base l'existence d'un stéréotype associé à une catégorie de personnes, ici la schizophrénie.

37) ODD et santé :

- A) Objectif 3 : santé et bien-être à tout âge
- B) Objectif 1 : santé des enfants et bien-être
- C) Objectif 5 : sécurité alimentaire, nutrition, agriculture durable
- D) toutes les réponses sont justes

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



38) Interventions de prévention secondaire :

A) dépistage du cancer du sein > 50 ans

B) apport de calcium après fracture

C) sport à l'école < 18 ans

D) arrêt tabac adultes > 18 ans

Niveaux de prévention et objectifs	Primaire (I) Éviter l'apparition de la maladie	Secondaire (II) Éviter le développement de la maladie	Tertiaire (III) Éviter l'aggravation de la maladie
Objectif visé par rapport aux maladies, accidents et handicaps	Diminuer l'incidence (le nombre de nouveaux cas)	Diminuer la prévalence (le nombre de cas totaux)	Limitier les complications, séquelles et récidives
Périodicité d'intervention	Avant l'événement	À un stade précoce de développement	En aval de l'événement
Exemple de mesures	Campagne d'information et de sensibilisation, vaccination préventive	Dépistage précoce	Rééducation fonctionnelle et réadaptation

39) Accident d'exposition au sang :

A) accident de travail

B) notifié au médecin de travail

C) déclaré sous 72h

D) déclaré sous 24h à 48h

E) concerne uniquement professionnels de santé

AES
Accident exposant au sang

Conduite à tenir en cas d'accident avec exposition au sang

Qu'est-ce qu'un AES ?

Tout contact avec :

- > du sang
- > un liquide biologique contenant du sang
- > un liquide biologique non visiblement souillé de sang mais considéré comme potentiellement contaminant tel que liquide céphalo-rachidien, liquide pleural, sécrétions génitales...

lors :

- > d'une piqûre ou d'une coupure avec un objet contaminé (seringue, scalpel...)
- > d'un contact sur peau lésée
- > d'une projection sur une muqueuse (œil, bouche, nez)

3 Dans les 24 heures

- Informer votre hiérarchie.
- Déclarer l'accident du travail.
- Suivre les recommandations du médecin pour votre suivi clinique et sérologique.
- Informer votre médecin du travail notamment pour effectuer l'analyse des causes de l'accident afin d'éviter qu'il ne se reproduise.

40) Cancers les plus fréquents au Maroc :

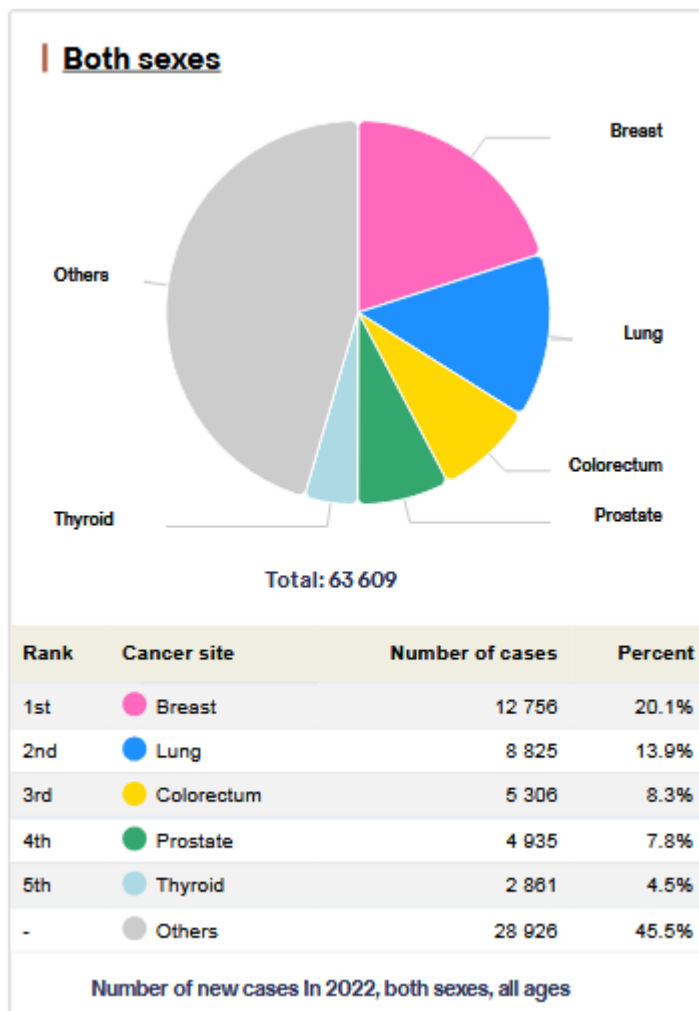
A) prostate, col utérin, poumon

B) poumon, sang, os

C) col utérin, sein, poumon

D) sein, côlon, peau

E) aucune réponse juste



41) Lavage antiseptique des mains vise à :

- A) éliminer flore transitoire
- B) détruire agents infectieux non conventionnels
- C) diminuer flore commensale
- D) toutes les réponses sont justes

Le lavage antiseptique des mains

Buts

- Eliminer la flore transitoire
- Diminuer la flore résidente.

Indications

- Après contact avec un patient en isolement septique avec son environnement.
- Après tout contact accidentel avec du sang ou des liquides biologiques.
- Avant la réalisation d'un geste invasif, acte stérile (pose cathéter, pose sonde urinaire, pansements ...)
- Entre deux patients, après tout geste potentiellement contaminant.

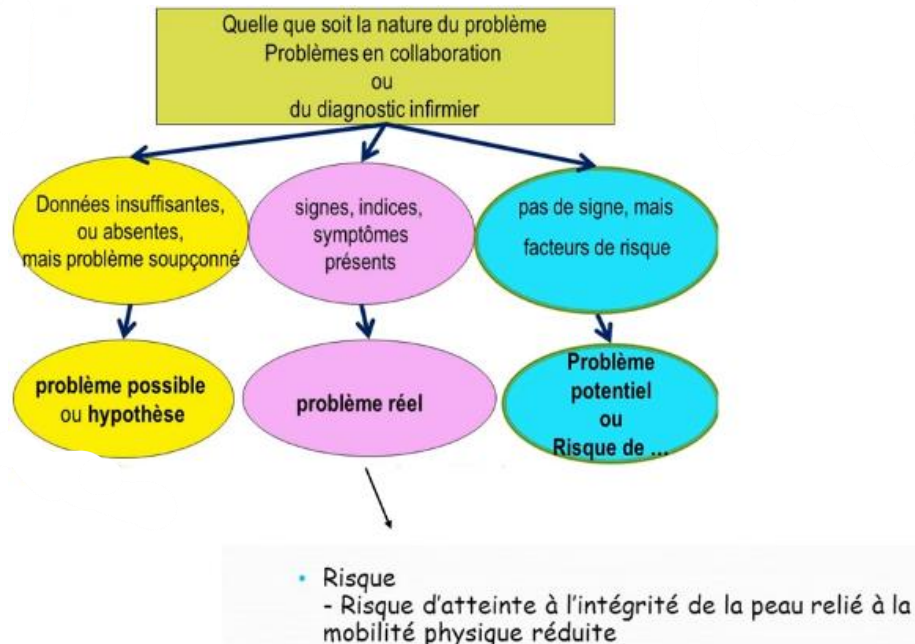
42) Diagnostic infirmier : atteinte intégrité peau par rougeur aux points d'appui :

A) potentiel

B) réel

C) possible

D) risque



43) Le ministère de la Santé au Maroc comporte 12 directions centrales et 09 directions régionales :

A) vrai

B) faux

ORGANISATION DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE :

